

境界性パーソナリティ症 家族の手引き

Multiple Family Group Program at McLean Hospital By John
G. Gunderson, M.D. and Cynthia Berkowitz, M.D.

New England Personality Disorder Association

訳 埼玉県立精神医療センター 富岡悠

目次

- 目標設定: ゆっくり進め
 1. 変わることは難しい
 2. 期待値を下げる
- 家庭での過ごし方
 3. 落ち着いて冷静になろう
 4. 家族で過ごすのをやめない
 5. 話すきっかけを見つける
- 危機に対処する- 注意を払いつつ冷静に
 6. むきになって反論しない
 7. 自己破壊的行動には・・・注意を払おう
 8. 話をきこう
- 問題に向き合う- 協力しあい、一貫性を持つ
 9. 家族の問題を解決するための3つの“必須条件”
 10. 家族と協力しながら行動しよう
 11. 医師/カウンセラーとのコミュニケーション
- 限界設定- はっきりと、でも慎重に
 12. 限界設定・・・我慢する限界をきめる
 13. おきてしまった事は本人の代わりに引き受けない
 14. 暴力的行為を我慢しない
 15. 脅しと最後通牒

目標設定: ゆっくり進め

1. 変わることは単に難しいだけでなく強い不安も付いてまわるものだと覚えておきましょう。「“すごく”進歩しているね」と言ったり「あなたならできる」と励ましたりするのには慎重になりましょう。病状が良くなることは、見捨てられ不安を呼び起こすものなのです。

境界性パーソナリティ症(Borderline Personality Disorder; BPD)を持つ人の親なら数え切れないほど経験している話ですが、子供が上手に適応したり義務を果たすようになってくると、そのすぐ後に危機が訪れるものです。病状改善とその繰り返しが連なって起きるのは理解しがたく苛立たしいものですが、それらが相次いで起きるのには理由があります。働きはじめる、施設を離れる、家の手伝いをする、自己破壊

(謝辞) 本手引きは、著者らによる下記文献の一部を再編集したものである。

“Family Psychoeducation and Multi-Family Groups in the Treatment of Schizophrenia,” McFarlane W. and Dunne B., eds, Directions in Psychiatry 11: 20, 1991.

的行動をやめる、一人暮らしを始めるといった生活の進展がみられるとき、子供はより自立した立場に立つことになります。周りにいて、支援したり、心配したり、守ったりしてくれた人たちが自分達の仕事は終わったと判断し、離れていってしまう危険を冒しているわけです。精神的支援は徐々になくなり金銭的支援もやがて底をつき、全て自分でやりくりしないといけなくなる可能性もあります。すると、見捨てられるのではという恐怖が生じます。その恐怖への反応が病状の再燃なのです。意図的に病状を再燃させるわけではないですが、不安や恐怖にかられると以前のような対処法をとりたくなります。連続欠勤、自傷、自殺企図、過食嘔吐発作、飲酒はその人がまだ辛い状況にあり、助けが必要であると周囲の人々に知ってもらうためのサインである可能性があります。そうした病状の揺り戻しが起きると周囲の人々は本人のために、やむを得ず入院のような保護的手段をとらざるをえなくなります。一旦入院すると他の人に世話をしてもらえするため本人は何においても責任を持たず、心的に退行しきった状態に逆戻りすることになるのです。

改善の兆しのある時に揺り戻しのリスクを減らすため家族にできることは、その進歩に浮き足立つことなく本人に対して慎重になるよう促すことです。境界性パーソナリティ症の患者が病院を退院する際、経験をつんだ病院スタッフは楽観的な見通しではなく、彼らに数々の困難が待ち受けているとこちらも分かっているということを患者に話しますが、それはこうした理由からです。改善していることを評価し、認めることも重要である一方で、それがいかに困難かを理解していると伝えることも必要なのです。状態が改善していても精神的苦痛を克服したということでは必ずしもないのです。「ものすごく良くなったね」「まるで別人になっていて感心したよ」といった言い方はやめましょう。そうした言い振りから暗に伝わるのは、本人がもう良くなっていて問題を克服したと思っているということです。「そんなに大変じゃなかったでしょう」「できると思ってたよ」といった安心させるための言葉がけでも、彼らの苦悩を軽んじているように聞こえるものです。「よくなったのは凄く頑張ったからだね。大変だったでしょう。よくなっているのは嬉しいけど、かえってストレスが増えてないか心配だな」といった言い方であれば、より共感的になり相手を傷つけるリスクは少なくなるでしょう。

2. 期待値を下げ、到達可能で現実的な目標を定めましょう。大きな問題は小さい段階にわけて解決するようにして、二つ以上の課題に同時に取り組まないようにしましょう。長期的で「大きな」目標設定は、やる気をそぎ、失敗につながります。

BPD を持つ人が知性、野心、美貌、芸術的才能といった多くの強みを備えていた場合でも、そうした才能を生かそうとする際に精神面での脆さが足かせになります。BPD を持つ人やその家族が夢見る将来像は、本人の強みに基づいていることが多いです。本人や家族は経済的自立の準備のために、大学や大学院や就労プログラムへの復帰をがむしゃらに追い求めることがあります。本人が自分で借りた部屋に引っ越して、家族に依存せずに自分の面倒をみるようになることを家族が望んだのかもしれない。そうした大きな成功願望に焚付けられると BPD を持つ人は一気に大胆な行動にでます。たとえば、退院した直後に大学にフルタイムで復学することを主張するかもしれません。当然そのような大きな計画は、情動不安定性、全か無か思考、孤独への脆弱性といった本人の持つ弱点を考慮に入れていません。この例でいえば、情動不安定性の影響で最初のテストで B をとった際に不公平だと感じ怒り狂ったり、大失敗だと感じ自己破壊的行動をとったり、学業が順調なら親の注意が離れると思込み極度の不安に陥ったりするかも知れません。仕事面での成功における最も大きな問題は自立への恐れです。というのも、自立することは念願であっても見捨てられ不安を生じさせるからです。一度に過剰なほど大躍進すると玉砕して逆戻りの結果になりがちなのは、振り子が戻っていくのと似ています。再燃して病状が戻ることを何度も繰り返すと、場合によっては入院が必要になることもあります。

家族の重要な役割は患者本人が目標を達成しようとするペースを緩やかにすることです。緩やかなペースは先程の例のような振り子の急な揺れ戻しから、挫折によって本人が自信喪失する機会を減らします。期待値を下げて段階的に達成できるような小さい目標をたてることは、病状再燃せずに病状がよくなる確率を上げることにつながります。目標は現実的である必要があります。例えば大学の学期途中で勉強のプレッシャーでうつ状態になり自殺企図が切迫していた人が、その 2, 3 ヶ月後に全単位を履修して上手くいく可能性は非常に低いでしょう。安定するまで一度にとる講座は一つまでにするという方が、その人にとってより現実的な目標です。目標は段階的に達成可能である必要があります。BPD を持つ人が両親と離れて暮らしたことがなかったとすると、そのまま一人暮らしをするのは難しいかもしれません。一人暮らしのためのプランは、まず社会復帰用の施設に行き、次に管理人つきアパートに移るといった小さなステップに切り分けることができます。それぞれの環境でほどほどに安定が得られて初めて一人暮らしという大きなステップに進むべきでしょう。

目標は複数の段階に分けるだけでなく、一度に取り組むのは一段階だけにする必要があります。例えば、患者と家族の目標が学業と一人暮らしを達成することであった場合、2つのうち同時に取り組むのは片方に絞るのが賢明でしょう。

家庭での過ごし方

3. できるだけ落ち着いて穏やかでいましょう。相手を褒めるのは普通のことです。落ち着いて伝えましょう。意見の不一致も普通のことです。落ち着いて対応しましょう。

この項目は私たち NEABPD(全米境界性パーソナリティ症教育連盟)の教育プログラムにおいて最も重要なメッセージを忘れないようにするためのものです。それはすなわち、BPD を持つ人は拒絶、批判、意見の相違などの人間関係におけるストレスに耐える能力に障害を持っており、だからこそ穏やかで落ち着いた家庭環境が有効だということです。BPD を持つ人の毎日経験している感情的な困難がどれほどであるかを把握することは非常に重要です。彼らの内的な体験をうまく伝えるのは難しいですが、感情調節困難、孤独への不耐性、全か無か思考という三つの障害に整理して解説します。

感情調節困難：

BPD を持つ人の感情は一日のなかで急激に変動しやすく、かつ非常に激しいものです。こうした感情・情緒は強い苦痛をもたらすことが多いです。激しい感情に襲われることは誰にでもあります。例をあげると仕事上の大きなミスや恥ずかしいミスをしたことに突然気付いた時に、心臓がバクバクしはじめ不安な感覚が襲ってくる場合があります。BPD を持つ人はそうした強い感情を常日頃から感じています。殆どの人は埋め合わせをする方法が見つかるだろうと自分に言い聞かせるか、人間なんだからミスはするものだと考えるかして自分自身を落ち着かせることができます。BPD を持つ人は自分自身を落ち着かせる能力が不足しています。もう一つ例にあげられるのは家族同士の衝突です。だれでも愛する人々に怒りを覚えた経験があります。そういう状況では家族と真剣な話し合いをもつ機会をつくるよう工夫するなり、忘れてしまおうとするなりして自分をなだめるものです。このような場面でもBPD を持つ人は最大限の怒りを感じ、様々な方法で気持ちの整理をつけて自分自身を癒やすこともできないのです。結果的に不適切な形で表現することになるか、感情にまかせた行動（飲酒や自傷）に出ることになります。

孤独への脆弱性：

BPD を持つ人は、家族や治療者の休暇、恋人との破局、友人との別れといったことで人と距離ができる可能性があるが絶望的になるのが常です。家族や治療者や友人の不在によって大抵の人はさみしく感じるものですが、BPD を持つ人は激しいパニックに襲われるのです。そこにいない人を思い浮かべて自分を慰めるということができません。「あの人は私のことを気にかけているし、また戻ってきたら助けてくれる」と自分に言い聞かせることもできないのです。記憶は役に立ちません。その人がその場にいるときにだけホッとして、気にかけてもらえていると感じることができます。よって、その場に相手がいないことは見捨てられたことのように経験されます。解離と呼ばれる心的防衛メカニズムにより、このような苦しい思考や感覚を意識の外に追い出すこともありえます。現実感のない身体から離れてしまったような妙で不快な感覚もこれに含まれます。

全か無か思考（二元法的思考）：

極端な感情と共に極端な考え方も生じます。BPD を持つ人は極端な意見を持つ傾向があります。他の人を完全にいい人か悪い人かのどちらかだと感じがちです。ある人が気にかけて支えてくれるときには、その人のことを救世主で特別な資質をもっているのだと考えます。その人が何らかの形で期待にそむいたり、反対意見をいったり、認めてくれなかったりすると BPD を持つ人はその人のことを思いやりがなく悪意に満ちていると見なします。他人をより現実的にいいところとわるいところの混じったものだと捉えることができないことが障害なのです。

BPD を持つ人の障害について解説したのは、彼らのストレスに耐える能力に著しい障害があることを忘れないためです。それらを理解していることで家族は穏やかで落ち着いた家庭環境を築いて病状を安定させる支援ができます。すなわち、危機が起きたときに激しい感情で応えるのではなく速度を落として深呼吸する、過度なプレッシャーを与えないため小さなゴールを設定する、冷静なときに落ち着いてコミュニケーションをとる、といったことです。失望や異論については隠して議論を避けるということではありません。衝突が起きたら冷静かつ具体的にそれを取り上げつつも相手をけなすようなことは言わないことです。そのようなコミュニケーションをとる方法については後述します。

4. 日常生活において家族と過ごす時間はできるだけ減らさないようにしましょう。親族や友人とは連絡を取り合しましょう。生活は病気のことだけではないので、良い時間を過ごすことを諦めてはいけません。

重い精神疾患をもつ人が家族にいる際、その事で家族それぞれが孤立してしまうことはよくあります。問題の対処にも時間とエネルギーを吸い取られます。偏見の目にさらされて恥ずかしい思いをすると感じると、問題を隠すため友人と距離をおいてしまいがちです。そうして孤立した結果、怒りと不安だけが残ることになる場合もあります。友人、食事会、リラックスするための休暇は誰にとっても必要なものです。多少無理してでも快適な時間を確保することで、より良い観点を持ち落ち着いて人生の問題に対処できるのです。家の状況も自然とより穏やかになっていくでしょう。したがって良い時間を過ごすことは貴方のためだけではなく家族全体のためになることなのです。

5. 話をする時間を確保しましょう。軽くて当たり障りのない話題でもいいのです。必要なら時間を決めておきましょう。

家族が別の家族とケンカをしているときや重度の情動不安定性により疲弊しているときに、病気のこと以外の話をする時間をつくるのを忘れてしまうことは非常によくあります。そういう話をするのは多くの面で有用です。BPDを持つ人は毎週なんども治療に通ったりデイケアに通ったりと、自分の病気にすべての時間やエネルギーをとられてしまうことも多いです。結果的に自分の様々な才能や興味を生かす機会を逃してしまうことにもなります。そういう人の自己評価は悪いのが当たり前で、自分の問題にだけ目的意識が向かい、病気であることにだけ注意が注がれると自己評価はさらに悪くなります。家族が時間をとって病気以外のことも話すと励まされますし、自分の健康的な面や新たな関心が育つことを知ることができます。そうした話し合いは家族同士の対立を和らげることにもつながります。そうすれば本手引きの3番の内容も守りやすくなります。

そうした雑談が全くない家庭もあり、最初は話をするのが不自然で居心地悪く感じられるかもしれません。そのようなコミュニケーションの機会がなかった理由は千差万別でしょう。家族にとって一緒に話す時間は必要です。前もって決めた時間を紙に書き冷蔵庫のドアに張っておいてもいいかもしれません。例えば週に2回か3回はトラブルに関する話や口論はなしという取り決めで夜ご飯を一緒に食べるのもいいでしょう。やがて話すことは習慣になり、予定を決めておく必要もなくなるかもしれません。

危機に対処する－注意を払いつつ冷静に

6. 責められたり批判されたりしたときに、むきになって反論しないようにしましょう。傷ついた気持ちになってもいいのです。批判の中に当てはまることがあれば認めましょう。

愛情のある関係同士でも、お互い陰悪になれば怒りにまかせて酷い悪態をついてしまうことがあります。BPDを持つ人は強い怒りを感じる傾向から特にそうなります。不当だと感じる批判を受ければ、自分を弁護するために反論するのは自然な反応です。しかし、そのような状況で反論しようとしたことのある人なら誰でも分かっているように、その反論は効果的ではありません。怒っている人は落ち着いて理性的に別の視点から考えるということができません。反論は怒りの火に油を注ぐだけです。つまり、反論することで相手の怒りが不当だと考えていることを暗に伝えることになり、それがより強い怒りを呼ぶ結果になるのです。怒りを言葉で伝えている人が自分や他人に危害を加えようとしていないなら、一番賢いのは反論せずに黙って聞いていることです。

その人が一番求めているのは聞いてもらうことです。もちろん愛する相手が自分から不当な扱いを受けたと思っていると知るのは非常に辛いことであり、反論せずに聞くことで気分は悪くなるでしょう。非難の内容が率直にいつて間違っており不当なので傷つくこともあるでしょう。そうではなく、ある種の真実を含んでいるからこそ傷つくこともあるかも知れません。聞いていると正しいことも言っていると感じる場合は「あなたの言うことにも一理あると思う。わたしが傷つけたのはわかるよ。ごめんね」といった言葉でそれを認めましょう。

そうした怒りも BPD を持つ人々の病状の一部であることは覚えておきましょう。非常に怒りっぽい気質は生まれつきだった可能性もあります。怒っているのは瞬時に反転しうる感情が一方向へ振れたからかもしれません（全か無か思考の項を参照）。こうした点を頭にいれておくことで怒りを個人攻撃だと捉えることを避けられます。

7. 自己破壊的な行動やその脅しには注意を払いましょう。無視してはいけません。パニックになってもいけません。知ることができたのはいいことです。秘密にしてはいけません。そのことについて家族とオープンに話しあい、治療者にも知らせてあるかを確認しましょう。

家族や本人が気付くことができるトラブルの予兆は様々です。自己破壊的行動の脅しやほのめかしには様々な問題行動が含まれます。死にたいと本人が話すこともあ

るでしょう。皮膚に薄いひっかき傷をつけることもあります。ひとりで籠もりがちになることもあるかも知れません。子供が強い精神的苦痛を感じている時期に、ときどき頭を剃って蛍光色に染めているのに気付く親もいます。食事を食べなくなったり無謀な行動に出たりする事もよくあり、より明白な徴候です。証拠が一目瞭然の時もあります。親がいる前で自殺しようとする素ぶりをみせる場合がそうです。別離や休暇の際もトラブルが予想される場合があります。

家族がトラブルの徴候をみつけた際に指摘するのを躊躇することもあるかもしれません。BPDを持つ人は家族に「口出ししないで」と強く訴えることがあります。プライバシーの権利があるんだからと言うかも知れません。一方、話し合いが難しいと考えて問題について率直に話すことを避ける家族もいます。いまは問題がないかもしれないのに「変なことをいってしまった」ばかりに問題が生じるのをおそれている場合もあります。実のところ親は子供のことをよく分かっていて経験からトラブルの予兆を知っているからこそ、こうした状況で子供の安全が心配になるのです。質問によって問題が生じることはありません。前もって家族が問題行動やそのきっかけに言及しておくことは、さらなるトラブルを回避することにも繋がります。BPDを持つ人は自分の感情について話すのが苦手なことが多く、破壊的な行動に出がちです。よって子供に尋ねたり治療者に連絡をとったりして問題について言及することは、行動より言葉を使って感情に向きあうことにつながります。

プライバシーは一人の大人を相手にする際、もちろん重要事項です。一方で上記のような危険を減らすべき状況においてプライバシーと両立しないのが安全です。安全がまず優先されるべきということには大抵の人が同意するでしょう。プライバシー尊重を口実に控えめの対応で済ませたくなることもあるかも知れません。一方で、かえって行動をエスカレートさせる程に過剰な対応をしてしまいたくなることもあるでしょう。ある若いBPDの女性は精神科病院へ向かう救急車の中で興奮し「救急車なんか乗ったことないのに！」と叫びつづけました。家族は個別の状況に合わせて判断力を働かせる必要があります。危機に対する心構えと個々の家族に合わせた対策について治療者に相談するのも有効です。

8. 話をききましょう。ネガティブな気持ちも人にきいてもらう必要があります。「そんなことないよ」は禁句です。気持ちを変えさせようとするのは止めましょう。恐怖、孤独、劣等感、怒りを表現する言葉を使うことは良いことです。感情を表すのに言葉を使うことは態度や行動で示すより良いことなのです。

率直な感情表現は聞くことがつらいこともあります。自分は見捨てられていたし愛されてもいなかったと子供が親に訴えることもあります。我慢の限界だと親が子供に言うこともあります。感情的になった人が落ち着くためには聞くことが最善の方法です。聞いてもらい自分の気持ちを知ってもらうことで人は感謝します。これは相手に同調しないといけないということではありません。傾聴の仕方を学びましょう。一つの方法は相手に関心を持ち気遣う様子でいつつ静かに聴き続けることです。関心を持っていることを伝えるために、いくつか質問をしてもよいでしょう。例えば「いつからそんな風に感じていたの」「何がきっかけでそんな気持ちになったの」と尋ねてもいいでしょう。こうした態度や質問が示すのは関心があることであり同意ではありません。傾聴のもう一つの方法は自分が受け取った内容を言葉で表現することです。そうした言葉により実際に相手がいうことを聞いているのだとはっきり示すことになります。例えば子供が自分は愛されていないと訴えたら、その思い込みが何て馬鹿げているんだと思いつつ「私が愛してないと思っていたの！？」と聞き返すこともできます。自分だけ大事にされていなかったと子供が親に話したときには「裏切られたような気持ちなの？」と返してもいいでしょう。繰り返しになりますが共感的な言葉をかけることは同意することではありません。

みだりに子供の感じたことについて言い争ったり説得して気持ちを変えようとしたりはいけません。上に述べたように話を聞いて欲しい人にとって反論されるのは不毛でしんどいものです。子供の主張が現実には全く根拠がなく、その思いを認めるのが難しいと感じる時であっても、表現したことに対し報いることは損にはなりません。人々にとって特に BPD を持つ人たちにとって感情を言葉にすることは、どれだけゆがんだ認知に基づいていたとしても良いことなのです。言葉で感情を表現することに意味があると思えば、感情にまかせて破壊的行動を起こすことは少なくなるでしょう。

孤独感、疎外感、劣等感は聞いてもらう必要のある感情です。それらを傾聴し、上に述べたような方法で聴いていることを示すことで、本人の感じる孤独感や疎外感が和らぎます。そうした感情は BPD を持つ人は当たり前のように毎日経験するものです。たいていの親は子供がそのように感じていることに気付いてないか、そうと信じたくないと思っています。感情による苦しみは一旦人に話せば、少しだけ和らぐものです。

家族の誰かがすぐに反論・否定するか、どうにか説得することで気持ちを変えさせようとするかもしれません。そのようなやり取りは気持ちを表現した人をととても怒らせ、そしてガッカリさせることになります。感情を言葉にした際に否定されれば、本人は周りに分からせるため行動で示さなければならなくなるかも知れません。

問題に向き合う – 協力しつつ、一貫性を持つ

9. 家族の問題を打開するために“必ず”やるべき3つのこと

- 1) 何をすべきかを明らかにするために、本人も関わる
- 2) 解決のために必要なことを本人が実行できるかどうかを訊く
- 3) 本人がやるべきことをやるのに自分の助けが必要かどうかを訊く

問題を打開するのに最も有効なのは家族同士の開かれた議論です。本人を含めた家族全員が議論に参加する必要があります。参加するよう頼まれ問題の解決に自分の意見が尊重される場では、人はその役をこなそうとするものです。

計画された打開策の中身に関して、やれそうかどうかを本人含めどの家族にも訊いておくことです。訊くことで相手にとっていかに難題かを分かっていると示すことになります。これは変化の難しさを認めることにも通じます。

介入して本人を助けたいという強い衝動に駆られる家族もいるでしょう。そうした助けは感謝されることもあれば、不要な押しつけと取られることもあるでしょう。介入する前に助けが欲しいかを訊くことで相手を怒らせる可能性は下がります。

10. 家族はお互いに協力して動く必要があります。両親の足並みがそろわないと家族トラブルはさらに燃え上がります。皆が協力できるような対応策を考えましょう。

BPD を持つ人について家族同士が完全に異なる見方をすることもあります。それぞれが別の見方に基づいて行動するとき、お互いの努力が打ち消し合うことになります。その結果起こりがちなのが家族間の対立は深まり不満も強くなる一方で、問題の克服には一歩も進まない状況です。

説明のために例をだしましょう。お金の無心のため娘がしょっちゅう電話をかけてきました。クレジットカードの負債はかなりの額に膨らんでいました。新しい服は

欲しくなります。家賃を払うための十分なお金を貯めておくこともできません。彼女は常にお金を欲しがっていましたが、仕事を辞めずに続けることも計画的に出費を減らし経済的に自立することも無理でした。父親は頑なな態度で資金提供を拒み、求められる度に自分自身で問題を解決すべきだと主張していました。一方で母親は要求すると毎回すぐに態度を軟化させ、欲しがる分だけのお金をわたしていました。追加の金銭的援助は娘の精神的ストレスを緩和する一つの方法なのだと母親は思っていました。そのため父親は母親が限度を設定する努力を台無しにしていると腹を立てましたが、一方で母親は父親の態度が厳しすぎて病状悪化の原因になっていると責めました。両親がぶれずに続けられる娘の経済問題に関する一貫した方針がないため、当然ながら娘の行動は変わりませんでした。話し合いを重ねた結果、母親からみて厳しすぎず、かつ父親の目からみて寛大すぎもしない適切な額で金銭的支援を行うという方針を立てました。両親がひとつの方針に従うことができるようになって初めて、娘もその方針に従うことができました。

兄弟や姉妹がこうした家族同士のトラブルに関わるうちに、問題への対処をめぐり衝突する場合があります。そのような状況では問題に関する異なる見方について家族で率直に話し合い、お互いの異なる意見を聞いてから皆が守れるような方針を組み立てる必要があります。

11. 薬や治療法について心配事があれば、本人と治療者（カウンセラー／医師／病院スタッフ）の両者と共有しましょう。あなたが支払い責任を負っている立場であれば医師やカウンセラーに心配事を伝える権利があります。

家族は本人の薬の使い方について様々な心配や懸念を抱くことがあります。本人の経験している副作用に精神科の主治医が気付いているのだろうかとかきもきすることもあるでしょう。本人の経験する眠気や体重増加を主治医は把握できているのだろうか、処方されている薬剤が多くてかえって危ないんじゃないか、本人が服薬を遵守しないことや薬物乱用歴があることを医師やカウンセラーは知っているのだろうかとか家族や友人が危ぶむこともあるでしょう。

家族がそうした懸念を抱くときに口を出すべきでないと感じたり、本人から口出ししないでと言われていたりすることは多いものです。本人の生活において経済的支援、精神的支援をしていたり住居を共にしていたりするのであれば、本人の治療計画に参加する努力をすべきでしょう。そのために医師やカウンセラーに自分から直接連絡を取り懸念事項を伝えることもできます。治療者は18歳以上の患者の情報を本人

の同意なしに伝えることはできませんが、本人の家族や友人の報告を聞いて参考にはすることはできます。家族や友人が治療に参加する際は当然ながら本人の同意が前提になります。

限界設定-はっきりと、でも慎重に

12. 我慢できる限界を伝えることで限界設定を行いましょう。明快で簡潔な言葉で希望を伝えましょう。周りに何を期待されているかは教えてもらわないと分かりません。

相手にやって欲しいと思っていることは、はっきり分かるように説明する必要があります。本人にやって欲しいことが自動的に伝わっていると思い込んでいる人があまりにも多いです。そのような思い込みを捨て去るのが効果的なことがしばしばあります。

やって欲しいことを伝えるための一番のコツは、脅しの含みをもたせないことです。例えば「少なくとも一日おきにはシャワーに入って欲しい」と言ってみるのはいいでしょう。この言い方であれば期待されていることを実行する責任は相手にあることになります。こうした状況でやって欲しいことをやるように脅かしておきたいと家族が思うことはよくあります。何とかして説得するため「最低でも一日おきにシャワーを浴びないと出てってもらうから」と言ってしまうかもしれません。この台詞の第一の問題は言った側に義務が生じることです。「自分の義務を果たしなさい！」という意図とは反対に“相手”が義務を果たさなかったら“自分”が行動を起こすと言っていることになります。この台詞の第二の問題は言った人は脅しを実行する気が本当はないであろうことです。脅しは無内容で怒りを表すだけになっています。もちろん、家族が本当に実行する意図をもって最後通牒を出さざるを得ないと感じる段階もあることでしょう。その場合については後述します。

13. 本人の行動により起こるべくして起こったことから本人を守ってはいけません。現実を学ぶ機会を与えるべきです。壁にぶつかる経験もときには必要です。

BPD を持つ人は危険で有害で代償の大きい行動にのめり込むことがあります。本人や家族の負う感情的負荷や金銭面での負担は甚大なものになることもあります。しかし、ときに家族は本人の望みを実現し、受けた損害を埋め合わせ、周りも含めて恥をかかないように何でもしてやる必要があります。こうした防衛手段をとれば、

ややこしい結果になるものです。第一に、問題行動は続くことになるでしょう。そうした行動で本人に何の損失もないばかりか、ある種の報酬も得ることになるからです。第二に、子供を守るためにけじめもなしにお金と善意を無駄遣いしたことで家族がかんかんに怒ることになるでしょう。こうした場合、それが家族間の対立を避けるためにやったことだとしても、かえって対立が深まる結果になります。一方、怒りを向けられることが本人にとってある種の報酬になることもあります。なぜなら、それが例えネガティブなものであっても注目を集めることになるからです。第三に、家の外でも本人がそうした行動をとるようになれば、家で受けるよりもっと深刻な損害や損失を実社会で本人は受けることになります。つまり、守ろうとすることで本人は現実世界に対する準備ができないままになってしまうのです。ポイントを示すために例をいくつか挙げます。

娘が母親のいるところで手一杯の錠剤を口に詰め込みました。母親は手を娘の口の中にいれて錠剤を掻き出そうとします。こうして医学的に危険な状態を防ぐのは理にかなっています。次に母親は娘が自殺を図り自らを傷つける恐れがあるため、救急車を呼ぼうと考えました。しかし、その選択肢をとれば非常にネガティブな影響が生じる可能性もありました。家の前に救急車が停まることで本人も家族も気まずい思いをするでしょう。娘は病院へ行くことを嫌がっていたため、救急車が呼ばれたら怒り狂って手が付けられなくなる可能性もありました。母親は娘に激怒され近隣からの評判も落とす事態を避けるため、この状況でも救急車を呼ばずに済ませたくなるでしょう。母親は娘に差し迫った危険があるわけでないのだと自分を納得させ、自らの判断を正当化するかも知れません。そうした選択をすることの一番の問題は、娘が自殺しようとして再び試みる可能性もあるのに必要な援助を遠ざけてしまうことです。問題を受け入れないことで娘の行動を助長することになるかも知れません。子供に自らを傷つける危険がせまっているかどうかを判断するには医学的な専門知識が必要です。大騒ぎしても娘が十分に注意を引きつけられなかった場合、その行動はエスカレートする可能性が高いです。行動がエスカレートすると、より派手な騒ぎをおこすようになり、より大きな怪我をすることになるでしょう。さらに言えば、怒らせたくないからといって救急車を呼ばないと、娘は怒るぞと脅すことで他者をコントロールできるというメッセージを受け取ることになるでしょう。

実家住まいの25歳女性は家族の金をこっそり盗んでいました。家族はとても怒り家から出て行ってもらうことになるぞと彼女を脅しますが、具体的に何かアクションを起こすことはしません。彼女がお金を借りたいという事実これまでお

金を返したことがないにもかかわらず、お金を渡していました。もしお金を貸さなくなったら家の外で誰かから盗んで警察沙汰になり、家族皆が巻き込まれるのではと不安に感じていました。この例では、家族が娘にお金を盗んでも罰を受けないのだという認識を与えてしまっています。本質的に彼女がやっているのは脅しです。不安に支配された家族は娘が望むものを与えてしまっています。許容できる限度を決めておかなければ、娘の行動は続く可能性が高いでしょう。家を出るよう強く要求するか、お金を貸すのをやめるといった手段で娘を守る事を止めることも家族はできるでしょう。家の外で盗みを働いて警察沙汰になったら、それが現実を知るための教訓になることもあるでしょう。警察沙汰が本人に変化をもたせれば、後々に家の外で上手に生活することにも繋がります。

最近まで精神科に何度も入院していた 20 歳で無職の女性が、フルタイムで大学に復学することを決めました。そして親に学費を援助してほしいと頼みました。ほぼ一日中ベッドにいる娘が一学期学校に行き続け単位を取ることが果たしてできるのか、親は疑問に思っていました。学費の支払いは相当な金銭的負担になります。にもかかわらず復学の計画を援助することに同意したのは、娘のふるまいが本当の具合の悪さから起きているのだと認めたくなかったからと、反対すれば本人を怒らせることになると思ったからでした。親は「あなたならできるよ」という危ういメッセージを出します。さらに本人が怒れば親の選択肢をコントロールできるということも示したのです。本人がやれることを証明するためにまずは一つの講座だけ履修し、感情調節困難があっても約束を守る能力があることを証明してからフルタイムの復学を行う方が現実的な計画だったでしょう。そのような計画であれば、本人はほとんど動けなかった最近の病状に向き合わなければならなくなります。希望する扱いを受けるために本人が責任を負うことを求める計画といえます。

どのケースも子供が無謀な選択をしたり、単に危険な行動をとったりしたときに守ってしまうことの弊害を例示しています。家族はそうした選択や行動に関して限界設定を行うことで、本人が責任を負い自分自身に適切な制限をかけるよう動機づけることができます。限界設定を行うという決断は家族にとって最も困難な決断となることも多いです。そうすれば本人が苛立ちや怒りに苦しみながら奮闘する様子を見守ることになります。そうした苦しい感情を子供に味合わせないようにするのはなく、誰しもやらなければならない苦しい感情ともに生きることを教えることが親の仕事だと覚えておくことは重要です。

14. キレて暴れる、威嚇する、殴る、つばを吐くといった暴力的行為を我慢してはいけません。その場から立ち去りましょう。そして問題については後で話し合しましょう。

キレて暴れる行為は我慢できるものではありません。そこに歯止めをかける方法は様々です。穏当な意思表示のやり方のひとつは暴れることで注目が得られるのを避けるために部屋から出て行くことです。より踏み込んだ意思表示としては、救急通報の電話をかける¹という方法もあるでしょう。多くの人は家の前に救急車両に停まって欲しくはないし、キレて暴れている本人の怒りをさらに焚付けたくもないので後者の方法を取るのを躊躇します。そのような感情にさいなまれたときには対立する問題も考える必要があります。誰かが暴力的になり手がつけられない状態になれば安全が危惧されることもあります。身体的危険を避けることのほうがプライバシーよりも優先順位は高いことには殆どの人が同意するでしょう。それに加え、行動のコントロールができないような状況でも適切な医療にかかることをしなければ、問題に対して蓋をすることになります。それでは行動がさらにエスカレートするだけです。問題行動は助けを求める叫びです。もし助けを求めて叫んでも聞こえていない様子なら、もっと大きな声で叫ぶようになるものです。

15. 脅しや最後通牒を使うことには慎重になりましょう。それは最後の手段です。説得のために使うのはやめましょう。最後通牒を出していいのは、その内容がやれることで、やる決意がある時だけです。どういう場合に出すかは専門家を含む他の人たちにも相談をしましょう。

本人の行動に耐えるのはもう限界だというとき、ある段階で最後通牒を出すことがあるかもしれません。つまり、本人が協力しなければ何らかのアクションを起こすと宣言するということです。例えば子供が風呂に入らない、あるいは朝起きてこないのが毎度のように続いた時、親は怒り心頭で行動を改めないと家から出て行ってもらうよと言いたくなることもあるでしょう。恐怖心から行動を改めてくれるだろうと期待するかもしれません。その一方、脅しの内容については真剣に考えているわけではないでしょう。子供が協力を拒み続ければ親は降参し、結果的に脅しがハッタリだったと示す結果になるのです。このように最後通牒を使うことは役に立たず、関係を悪化させるだけです。よって、最後通牒を出すのは真剣にそれを実行す

¹ 訳注 精神科の救急受診が必要なとき、日本では地域ごとに設置された精神科救急情報センターが窓口になりますが、暴れたり自分を傷つけたりするような行為が切迫し、緊急性が高い場合は警察への 110 番通報が可能です。

る気があるときだけにして下さい。本人の行動を我慢して生活するのはもう耐えられないという段階なら、最後通牒を出すことを真剣に考えていいでしょう。